TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

BỘ MÔN NGOẠI

BỆNH ÁN NGOẠI KHOA

HỌC VIÊN : NGUYỄN LONG NHẬT

LỚP : CKI - K51

CHUYÊN NGÀNH : Sản Phụ Khoa

HÀ NỘI 2026

CamScanner

I. HÀNH CHÍNH

1. Họ và tên: LÊ DOÃN CÂN Giới: Nam Tuổi: 70

2. Nghề nghiệp: Nghỉ hưu

3. Địa chỉ: Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám - Hà Nội

4. Người liên hệ: Con Lê Doãn Thái Bình 0532482340

5. Ngày vào viện: 16/10/2026

6. Ngày phẫu thuật: 16/10/2026

7. Ngày làm bệnh án: 21/10/2026

II. LÝ DO VÀO VIỆN

Đau bụng vùng mạn sườn phải

III. BỆNH SỬ

Theo lời BN kể lại, khoảng 19h ngày 15/10/2026 (1 ngày trước khi vào viện), BN xuất hiện đau bụng vùng mạn sườn phải, đau âm ỉ, liên tục, lan lên vùng thượng vị, đau nhiều hơn khi vận động, đau kéo dài không dứt, tăng dần về cường độ trong ngày hôm sau khiến BN phải vào Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 16/10/2026 Ngoài ra BN không sốt, không nôn, không buồn nôn, ăn uống được ít, đại tiểu tiện bình thường.

Tại viện khám thấy: BN tỉnh, tiếp xúc tốt. Da niêm mạc hồng. Không phù, không xuất huyết dưới da. Không sốt. Ấn đau trên vùng mạn sườn (P). Phản ứng thành bụng (+). Các cơ quan khác chưa phát hiện bất thường. Mạch 98 l/p, HA 152/86 mmHg

Xét nghiệm: t° 36.9°C, thở 16 l/p

- Công thức máu: Bạch cầu 16.56 G/L (↑) NEUT 14.6 G/L (↑) (89.9%), hồng cầu 5.04 T/L, Hb 149 g/L, Tiểu cầu 325 G/L

- Hoá sinh: AST 46 U/L, ALT 81 U/L, Bilirubin

toàn phần 9.3 µmol/L, Bilirubin trực tiếp 5.6 µmol/L ...
ure 5.1 mmol/L, Creatinin 6.5 µmol/L, CRP 9.48 mg/dL
Chức năng đông máu và chức gan đều bình thường
- Siêu âm bụng: Túi mật căng nhẹ 94x38 mm, thành dày quanh chu vi 5 mm, lắng đọng cholesterol thành túi mật, trong lòng có bùn và vài sỏi đường kính 19 mm, ống cổ túi mật có vài sỏi nhỏ đường kính lớn nhất 4 mm, nhiều mỡ nhẹ xung quanh
- CLVT bụng: Hình ảnh túi mật căng, đường kính 43 mm, thành dày quanh chu vi 5 mm, kết hợp siêu âm trong lòng túi mật có bùn và sỏi mật, ít dịch dọc rãnh đại tràng lên dày nhất 5 mm
Chẩn đoán trước mổ: Viêm túi mật cấp do sỏi
BN được chỉ định phẫu thuật nội soi cắt túi mật;
- Vô cảm: Mê nội khí quản
- Tiến hành: Đặt 4 trocart. Kiểm tra bụng nhiều dịch dưc và giả mạc ở dưới gan và dọc rãnh đại tràng phải, phúc mạc nhẵn, gan 2 thùy bình thường, túi mật thành dày, có điểm hoại tử đen, sỏi kẹt cổ túi mật. Tạm bộ cuống gan và đầu tụy viêm phù nề. Douglas có ít dịch dưc. Các tạng khác không có gì đặc biệt. Tiến hành giải phóng túi mật khỏi giường túi mật. Phẫu tích bóc lộ ống cổ túi mật. Cặp ống cổ túi mật bằng Hemaloc Hút rửa ổ bụng. Cầm máu kỹ. Đặt 01 dẫn lưu dưới gan. Lấy bệnh phẩm gửi giải phẫu bệnh, thao khâu, đóng trocart
BN sau mổ tỉnh, tự thở, huyết động ổn định

bụng mềm, dẫn lưu ổ bụng ra 15 ml. Không sốt.
Hiện tại ngày 5 sau mổ: BN tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, toàn trạng ổn định, đại tiện bình thường
IV. TIỀN SỬ
1. Bản thân:
- Sỏi túi mật nhiều năm chưa điều trị gì
- Viêm phế quản mạn tính
- Suy tim phân suất tống máu EF 61%
- Chưa phát hiện tiền sử dị ứng
2. Gia đình:
- Chưa phát hiện bất thường. Chưa phát hiện tiền sử dị ứng
V. KHÁM BỆNH
1. Toàn thân
- Tỉnh, tiếp xúc tốt
- Da niêm mạc hồng, không phù, không xuất huyết dưới da
- Không sốt
- Mạch 86 l/p, nhiệt độ 36,9°C, huyết áp 137/86 mm Hg, thở 16 l/p,
- Nặng 65 kg, cao 1,6 m
2. Bộ phận
- Tiêu hoá:
+) Bụng mềm, không chướng, di động theo nhịp thở
+) Vết mổ vùng mạn sườn phải và hạ vị kích thước 0,5-1cm khô, không phù nề
+) Dẫn lưu ra ít dịch không tương
+) Ấn vùng mạn sườn phải tức nhẹ. Phản

- Ứng thành bụng (-), cản ứng phúc mạc (-).
Dấu Murphy (-). Gan, lách không sờ thấy.
- Tuần hoàn: Tim nhịp đều, tần số 86 ck/p
Lồng ngực cân đối, tiếng T1-T2 đều rõ, chưa
phát hiện tiếng tim bệnh lý. Mỏm tim đúng vị trí.
- Hô hấp: Họ khạc đờm xanh, tự thở, nói
được câu dài, phổi ran ẩm/ran nổ vùng đáy
phổi.
- Tiết niệu: Chạm thận (-) Bập bềnh thận (-)
Rung thận (-) Hai hố thận không sờ thấy.
Khối (-) Không thấy điểm đau niệu quản.
- Thần kinh: Glasgow 15 điểm, không
có dấu hiệu thần kinh khu trú, dấu hiệu
màng não (-).
- Cơ xương khớp: Không đau, không hạn
chế vận động.
- Các cơ quan khác chưa phát hiện bệnh
lý kèm theo.

VI. CẬN LÂM SÀNG

1. Trước mổ (16/10/2026)

- Công thức máu: Bạch cầu 16.56 G/L, NEUT 14.6 G/L
hồng cầu 5.09 T/L, Hb 149 g/L, tiểu cầu 325 G/L
- Hoá sinh: CRP 94,8 mg/L, đ.l (T), AST/ALT
46 - 39 U/L, Bilirubin trực tiếp 56 µmol/L (T),
Bilirubin toàn phần 99 µmol/L
- Siêu âm bụng: Túi mật căng nhẹ 99 x 38 mm,
thành dày quanh chu vi 5 mm, lắng đọng
cholesterol thành túi mật, trong có bùn và vài
sỏi đường kính lớn nhất 9 mm, thâm nhiễm mỡ

Xung quanh.

- C.L.V.T. bụng: Hình ảnh túi mật căng, thành dày 4,3 mm, thành dày quanh chu vi 5 mm, thể hợp 8 cm trong lòng túi mật có bùn và sỏi mật, ít dịch doe lành đại tràng dày nhất 5 mm.

2. Sau mổ:

- Công thức máu: Bạch cầu 9,86 G/L, NEUT 7,46 G/L Hồng cầu 4,7 T/L, Hb 142 g/L, tiểu cầu 318 G/L
- Hoá sinh: CRP 10,83 mg/L dL.C.T., T10 point T (12,1), P10 BNP 1783 pg/mL
- Siêu âm: Hình ảnh còn thâm nhiễm mỡ quanh giường túi mật và hạ sườn phải
- Ngoài ra X quang có hình ảnh vôi hoá thuỳ trên phổi trái, dải xơ xẹp tái rác, giảm nhẹ thể tích phổi trái. Siêu cơm tìm thấy tràn quản E.P 3,6 %

VII. TÓM TẮT BỆNH ÁN

BN nam 70 tuổi vào viện vì đau bụng vùng mạn sườn phải ngày thứ nhất của bệnh.

- Tiền sử: Sỏi túi mật chưa điều trị, viêm phế quản mạn tính, suy tim
- Một ngày trước vào viện, BN xuất hiện đau vùng mạn sườn phải, đau âm ỉ, liên tục, lan lên thượng vị, tăng dần về cường độ. Khám bệnh đau tỉnh, mạch và huyết áp ổn định, không sốt. Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS): Nhiệt độ 36,9°C, Mạch 98 l/p, thở 16 l/p, Bạch cầu 16,56 G/L. Tam chứng Charcot không rõ. Đau bụng vùng gan, sốt (-), vàng da (-)

Phản ứng thành bụng (+). Cảm ứng phúc mạc (-)
Cận lâm sàng: Bạch cầu 16.56 G/L, NEUT 14.66 G/L
CRP 9.48 mg/dL, Bilirubin 5.6 umol/L
Siêu âm túi mật căng nhẹ, thành dày, lắng đọng cholesterol, trong lòng có bùn và sỏi, thâm nhiễm mỡ xung quanh. CLVT: Hình ảnh túi mật căng thành dày và các ổ áp xe gợi ý siêu âm
B.N được phẫu thuật nội soi cắt túi mật, vô cảm + Mê nội khí quản. Trong và sau phẫu thuật không xảy ra tai biến
Hiện tại ngày thứ 6 sau mổ, B.N tỉnh, tiếp xúc tốt, huyết động ổn định. Hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc thần (-). Bụng mềm, phản ứng thành bụng (-), Vết mổ khô, dẫn lưu ra ít dịch nhầy trong. Phổi ran ẩm/ran nổ vùng đáy. Các cơ quan khác bình thường
VIII. CHẨN ĐOÁN
Hậu phẫu ngày thứ 6 sau mổ nội soi cắt túi mật do viêm túi mật hoại tử do sỏi, hiện tại BN ổn định/ Đợt cấp giãn phế quản bội nhiễm - Theo dõi COPD - Suy tim mạn EF 36%
IX. ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI
- Kháng sinh: Meropenem
- Giảm đau
- Giãn phế quản/ khí dung
- Theo dõi tim mạch, huyết áp, SpO2, nhiệt độ, nước tiểu, dẫn lưu
- Theo dõi nhiễm trùng, công thức máu, CRP

- Ra viện: Dùng thuốc theo đơn, thay băng hàng ngày, cắt chỉ sau 7 ngày, tái khám sau 2 tuần.

X TIÊN LƯỢNG:

- Gần: Tốt sau mổ ổn định.
- Xa: Theo dõi hồi phục sau mổ, giải phẫu bệnh và dấu hiệu nhiễm trùng, bệnh kèm theo.

XI DỰ PHÒNG

- Hạn chế chất béo bão hoà và cholesterol.
- Tăng cường chất xơ và chất béo tốt.
- Uống đủ nước và ăn uống đúng giờ.
- Duy trì cân nặng hợp lý.
- Tăng cường hoạt động thể chất.
- Theo dõi và kiểm soát bệnh nền.